

TEMA 1.7 • PEDIATRÍA

Síndrome de Down (Trisomía 21)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.134

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Down (Trisomía 21)

Generalidades

- El **síndrome de Down** es la trisomía del cromosoma 21. Es la aneuploidía más frecuente compatible con la vida.

Factor de riesgo principal: Edad materna.

TABLA 1.7.1: EDAD MATERNA VS RIESGO APROXIMADO	
EDAD MATERNA	RIESGO APROXIMADO
30 años	1 en 1.000 (0,1%)
40 años	1 en 100 (1%)
50 años	1 en 10 (10%)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla mnemotécnica: **30-40-50 años** → **1/1.000 – 1/100 – 1/10**.
Cada 10 años sube un orden de magnitud.

Clínica

- Triada principal:**
- Hipotonía** (boca siempre abierta por la hipotonía)
- Facies característica**
- Discapacidad cognitiva** (variable en intensidad)
- Rasgos físicos característicos:**
- Epicantos** (pliegue en ángulo interno del ojo)
- Puente nasal deprimido
- Orejas de implantación baja
- Macroglosia** (lengua grande)
- Cráneo pequeño
- Mano de mono (mano simial):** pliegue palmar único transverso

NOTA CLÍNICA

La intensidad de los síntomas es muy variable de un niño a otro. La inteligencia puede estar solo levemente afectada en algunos casos.

Diagnóstico

Clínico: Reconocimiento de los rasgos físicos característicos.

Confirmación: Cariotipo (cariograma) → demuestra trisomía 21.

- Diagnóstico antenatal:**
- Ecografía 11-14 semanas** (translucencia nucal + marcadores bioquímicos) → tamizaje de aneuploidías
- Biopsia de vellosidades coriales** → cariotipo fetal si tamizaje alterado

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El síndrome de Down **NO es causal de aborto en Chile** (es compatible con la vida). Las trisomías 13 y 18, en cambio, son incompatibles con la vida y sí son causales de aborto.

Enfermedades Asociadas (siempre buscar)

TABLA 1.7.2: PATOLOGÍA VS ESPECIFICIDAD	
PATOLOGÍA	ESPECIFICIDAD
Cardiopatías congénitas	Canal aurículoventricular (CAV) es la más característica
Malformaciones gastrointestinales	Atresia esofágica, atresia duodenal, ano imperforado
Hipotiroidismo	Screening adicional obligatorio más adelante
Inestabilidad atlantoaxial	Riesgo de lesión medular cervical
Leucemia	Mayor incidencia
Alzheimer precoz	En adultos con SD

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un niño con SD que vomita desde el nacimiento → sospechar **atresia duodenal** (signo de "doble burbuja" en Rx).

Tratamiento

- Enfoque **multidisciplinario:** estimulación temprana, rehabilitación, educación especial
- Tratar las comorbilidades (cardiopatía, hipotiroidismo, etc.)
- Evaluación con tablas de crecimiento específicas para SD** (no usar tablas de población general para diagnóstico nutricional)
- En Chile: **Fundación Teletón** (también apoya a niños con SD)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"RN con rasgos dismórficos (epicanto, fisuras mongoloides, hipotonía, clinodactilia V dedo). A las 48h de vida presenta distensión abdominal y vómitos biliosos. Rx de abdomen muestra doble burbuja. ¿Cuál es el diagnóstico de la complicación intestinal?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome de Down (Trisomía 21). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Trisomía 21: no disyunción materna (95%); riesgo aumenta con edad materna >35 años
- Cardiopatía congénita en 40-50% de SD: canal aurículo-ventricular completo (CAV) es la más frecuente
- Malformaciones GI: atresia duodenal (imagen doble burbuja) y enfermedad de Hirschsprung
- Hipotiroidismo: 15-20% de niños con SD; TSH anual obligatoria desde el nacimiento
- Screening prenatal: translucencia nucal + PAPP-A + βhCG semanas 11-13; cariotipo confirma
- Inestabilidad atlantoaxoidea en ~15%: Rx lateral cuello antes de deportes de contacto

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE DOWN (TRISOMÍA 21))

PREGUNTA 1

RN con rasgos dismórficos (epicanto, fisuras mongoloides, hipotonía, clinodactilia V dedo). A las 48h de vida presenta distensión abdominal y vómitos biliosos. Rx de abdomen muestra doble burbuja. ¿Cuál es el diagnóstico de la complicación intestinal?

- ☐ A) Enfermedad de Hirschsprung
- ☐ B) Atresia de esófago
- ☐ C) Atresia duodenal
- ☐ D) Malrotación intestinal con vólvulo
- ☐ E) Íleo meconial por fibrosis quística

PREGUNTA 2

Niño de 3 años con diagnóstico de Síndrome de Down, sin cardiopatía conocida, asintomático. ¿Qué examen de seguimiento es obligatorio anualmente?

- ☐ A) Ecocardiograma anual
- ☐ B) TSH anual para screening de hipotiroidismo
- ☐ C) TC cerebral anual
- ☐ D) Audiometría cada 5 años
- ☐ E) Cariotipo anual para detectar mosaicismos

PREGUNTA 3

Pareja consulta por embarazo de 12 semanas. Screening combinado del primer trimestre muestra translucencia nucal 4.5 mm (>P99), PAPP-A baja y β hCG elevada. ¿Cuál es el paso siguiente?

- ☐ A) Repetir ecografía en 4 semanas
- ☐ B) Amniocentesis en semana 16 para cariotipo
- ☐ C) Biopsia de vellosidades coriales para cariotipo fetal
- ☐ D) Test de ADN fetal libre en sangre materna (NIPT)
- ☐ E) Tranquilizar a la pareja, riesgo bajo

RESUMEN: SÍNDROME DE DOWN (TRISOMÍA 21)

El síndrome de Down es la trisomía del cromosoma 21. Es la aneuploidía más frecuente compatible con la vida. ::tip Regla mnemotécnica: 30–40–50 años → 1/1.000 – 1/100 – 1/10. Cada 10 años sube un orden de magnitud. ::: Triada principal: 1. Hipotonía (boca siempre abierta por la hipotonía) 2. Facies característica 3. Discapacidad cognitiva (variable en intensidad)